

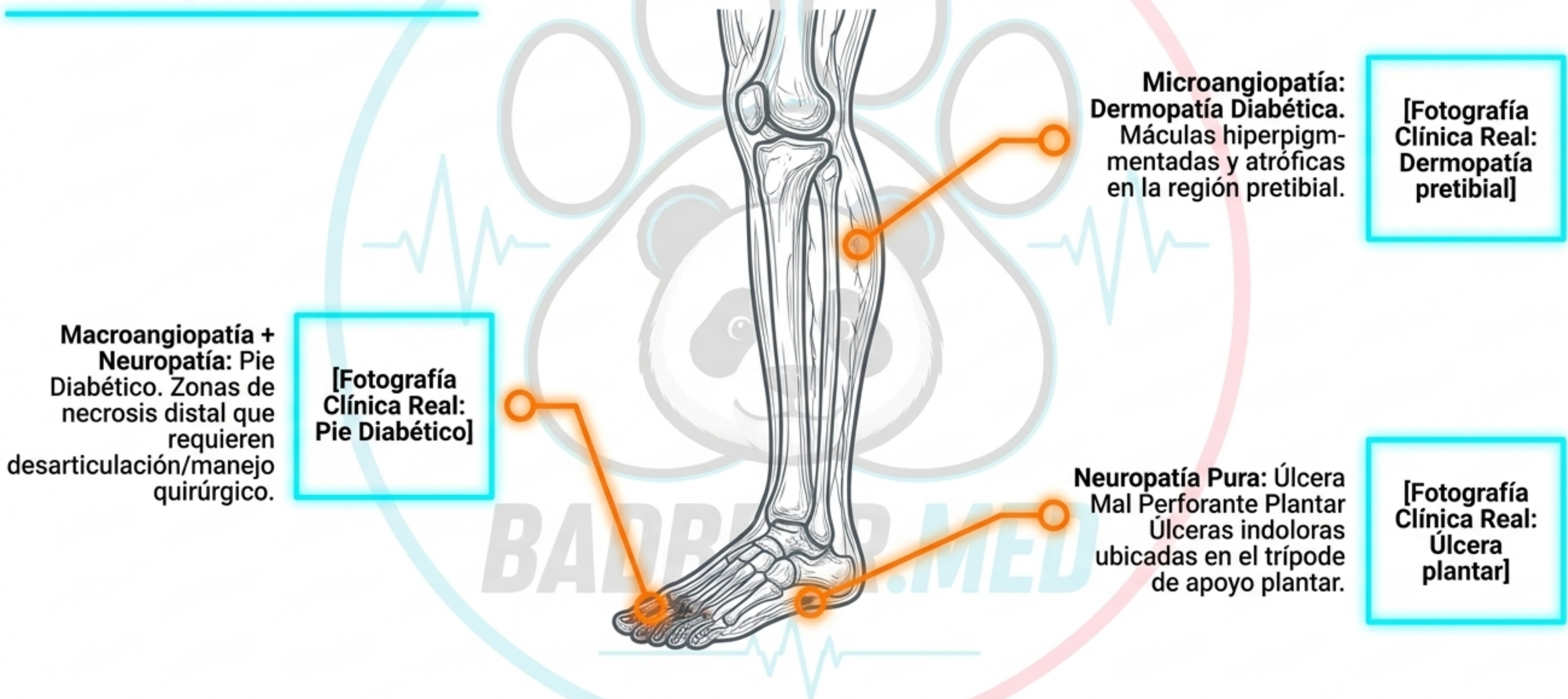


Manifestaciones Dermatológicas de Enfermedades Sistémicas

Atlas Clínico y Matriz Diagnóstica Estructurada

[Placeholder para Fotografía Clínica Real: Textura dermatológica abstracta o patrón vascular]

Diabetes Mellitus: Complicaciones Vasculares y Neuropáticas



Diabetes Mellitus: Manifestaciones Metabólicas y Lipídicas

Acantosis Nigricans

Piel engrosada, aterciopelada y oscura en grandes pliegues (axilas, cuello).

Refleja resistencia a la insulina.

Tratamiento: Pérdida de peso, queratolíticos, hidroquinona.

[Fotografía
Clínica Real]

Xantomas Eruptivos

Pápulas amarillentas por **hipertrigliceridemia** grave.

Infiltración de lípidos fagocitados por Células de Touton en la dermis.

[Fotografía
Clínica Real]

Xantelasmas

Pápulas amarillentas en el canto interno palpebral.

(**Nota:** 50% asociados a hipercolesterolemia familiar, no exclusivamente a diabetes).

[Fotografía
Clínica Real]

Granuloma Anular

Pápulas anulares eritematosas en **dorso de manos/pies**.

Histología: Colágeno degenerado sin empalizada completa.

[Fotografía
Clínica Real]

Trastornos Tiroideos, Suprarrenales y Ováricos

Hipertiroidismo (Ej. Enf. de Graves)

- **Piel/Anexos:** Eritema palmar (eminencias tenar/hipotenar), Acropaquia (dedos en palillo de tambor), Uñas de Plummer (onicólisis).
- **Signo Patognomónico:** Mixedema pretibial (depósito marcado de mucina).

[Fotografía Clínica Real]

Hipotiroidismo

- **Piel/Anexos:** Mixedema generalizado (no deja fovea), Piel seca/amarilla/pálida, Onicorrexis (uñas frágiles), Alopecia.
- **Facies:** Madarosis (pérdida del tercio distal de las cejas).

[Fotografía Clínica Real]

Eje Suprarrenal y Ovárico

- **Cushing:** Facies de luna llena, giba de búfalo, estrías atróficas.
- **Addison:** Hiperpigmentación parda en pliegues y bordes alveolares.
- **SOP (Síndrome de Ovario Poliquístico):** Acné resistente, hirsutismo, alopecia androgénica por hiperandrogenismo.

Autoinmunidad I: Lupus y Dermatomiositis

Lupus Eritematoso Sistémico (LES)

- ✓ **Eritema Malar:** “Alas de mariposa” clásico, respetando surcos nasogenianos. Exacerbado por exposición solar.
- ✓ **Fotosensibilidad:** Lesiones en zona anterior de tórax y áreas expuestas.
- ✓ **Fenómeno de Raynaud:** Secuencia isquémica (Blanco -> Azul -> Rojo) por exceso de endotelina-1.

[Fotografía Clínica Real: Eritema Malar]

Dermatomiositis

- ✓ **Eritema Heliotropo:** Coloración rojo-violácea con edema en párpados.
- ✓ **Signo de Gottron:** Pápulas eritematosas patognomónicas sobre los nudillos.
- ✓ **Signo de la V / Chal:** Fotosensibilidad en cuello y espalda superior.
- ✓ **Calcinosis Cutis:** Nódulos duros calcificados subcutáneos.

[Fotografía Clínica Real: Eritema Heliotropo]

Autoinmunidad II: Esclerosis Sistémica y Síndrome de Sjögren

Esclerosis Sistémica: Engrosamiento y esclerosis del colágeno dérmico por hiperactividad de fibroblastos. Conduce a 'Facies de pajarito' y microstomía.

[Fotografía Clínica Real]

Síndrome CREST - Forma Limitada

C

— **Calcinosis cutis** (depósitos de calcio).

R

— **Raynaud** (fenómeno isquémico severo).

E

— **Esofágica** (dismotilidad).

S

— **Sclerodactilia** (piel endurecida en dedos, imposible de plegar, propensa a úlceras).

T

— **Telangiectasias** (dilataciones capilares).

[Fotografía Clínica Real]

Síndrome de Sjögren: Autoinmune destructivo de glándulas glándulas exocrinas. Presenta xeroftalmía (ojo seco severo) y xerostomía (sequedad bucal).

Autoinmunidad II: Artritis Reactiva y Reumatoide

Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter)

Contexto: Respuesta autoinmune post-infecciosa (GI o genitourinaria) ligada a HLA-B27.

Balanitis Circinada:
Erosiones superficiales
indoloras en el meato
urinario.

Dactilitis: “Dedo en
salchicha” por
inflamación difusa.

**Queratoderma
Blenorrágica:**
Hiperqueratosis severa
palmoplantar.

[Fotografía Clínica
Real: Balanitis
Circinada]

Artritis Reumatoide

Nódulos Reumatoides: Nódulos firmes, a
menudo en dorso de manos/articulaciones.

Histología: Granuloma profundo con
histiocitos en empalizada y fibrina central.

Vasculitis Cutánea:
Compromiso exclusivo de
vasos dérmicos en fases
avanzadas.

[Fotografía Clínica
Real: Nódulos
Reumatoides]

Manifestaciones Renales y Hematológicas

Falla Renal Crónica (Uremia)

Aumento de PTH / Histamina

Prurito Urémico: Severo, refractario, con xerosis y escoriaciones por rascado intenso.

[Fotografía Clínica Real]

Retención hídrica

Signo de Godet (Fóvea): Hundimiento sostenido de la piel a la presión por edema.

Anemias Carenciales (Hierro, B12, Ácido Fólico)

Déficit en mucosas

Glositis Atrófica: Lengua lisa, brillante, depapilada.
+ **Queilitis Angular:** Fisuras en comisuras labiales.

[Fotografía Clínica Real]

Déficit en anexos

Coiloniquia: Uñas en cuchara (delgadas y cóncavas).
+ **Efluvio Telogénico:** Caída masiva del cabello.

Trastornos Gastrointestinales e Inflamatorios

Pancreatitis Aguda

Signo de Cullen: Equimosis periumbilical. Indica sangrado retroperitoneal grave.

Signo de Grey-Turner: Equimosis en flancos (mortalidad >70%).

[Fotografía Clínica Real]

Colitis Ulcerosa / Enf. Inflamatoria Intestinal

Pioderma Gangrenoso: Úlcera masiva, bordes violáceos irregulares. Falla quimiotáctica, sin causa bacteriana (responde a biológicos).

[Fotografía Clínica Real]

Enfermedad Celíaca

Dermatitis Herpetiforme: Erupción pápulo-vesicular intensamente pruriginosa (depósitos granulares de IgA).

Eritema Nodoso: Paniculitis (nódulos calientes/dolorosos, no ulcerados) en la cara anterior de las piernas.

Infecciones Sistémicas I: VIH/SIDA

Neoplasias

Sarcoma de Kaposi: Neoplasia angioproliferativa maligna multicéntrica inducida por VHH-8. Nódulos rojo-violáceos en piel y mucosas.

[Fotografía
Clínica Real]

Virales Exacerbadas

Leucoplasia Velloso Oral: Hiperqueratosis blanquea en bordes de la lengua (Virus Epstein-Barr).

[Fotografía
Clínica Real]

Herpes Zóster Atípico: Afección de múltiples metámeras o nervios motores.

Parasitarias

Escabiosis Costrosa (Sarna Noruega): Placas hiperqueratóticas masivas repletas de *Sarcoptes scabiei*, altamente endémico/contagioso.

[Fotografía
Clínica Real]

Efectos Adversos (TARGA)

Lipodistrofia: Redistribución grasa (Ej. pseudoginecomastia, atrofia geniana).

Infecciones Sistémicas II: Infección por HTLV-1

HTLV-1: Retrovirus y oncovirus que genera inmunosupresión profunda (CD4/CD8) y leucemia/linfoma de células T.

Dermatitis Infecciosa:

Eccema crónico, recurrente y severo que compromete rostro y cuero cabelludo, sobreinfectado por *S. aureus* y *S. pyogenes*.

[Fotografía Clínica Real]

Tumor de Buschke-Löwenstein:
Condiloma gigante malignizado (carcinoma verrugoso) inducido por VPH, agresivo localmente en áreas anogenitales.

[Fotografía Clínica Real]

Co-infecciones:

Sarna costrosa y candidiasis oral refractaria, amplificadas por la caída del sistema inmune.

Síndromes Neurocutáneos: Matriz Diagnóstica

Neurofibromatosis Tipo 1 (Enf. Von Recklinghausen)

- Manchas Café au lait (>6 manchas pre-puberales >5mm).
- Neurofibromas múltiples.
- Signo de Crowe (Pecas axilares).
- Nevus anémico (zona pálida que no responde a catecolaminas).

[Fotografía Clínica Real:
Manchas Café au lait]

Esclerosis Tuberosa (Enf. Pringle-Bourneville)

- Angiofibromas faciales.
- Manchas acrómicas ('Hoja de Fresno').
- Tumores de Koenen (fibromas ungueales en ajo).
- Triada clásica:
Angiofibromas + Epilepsia + Retraso mental.

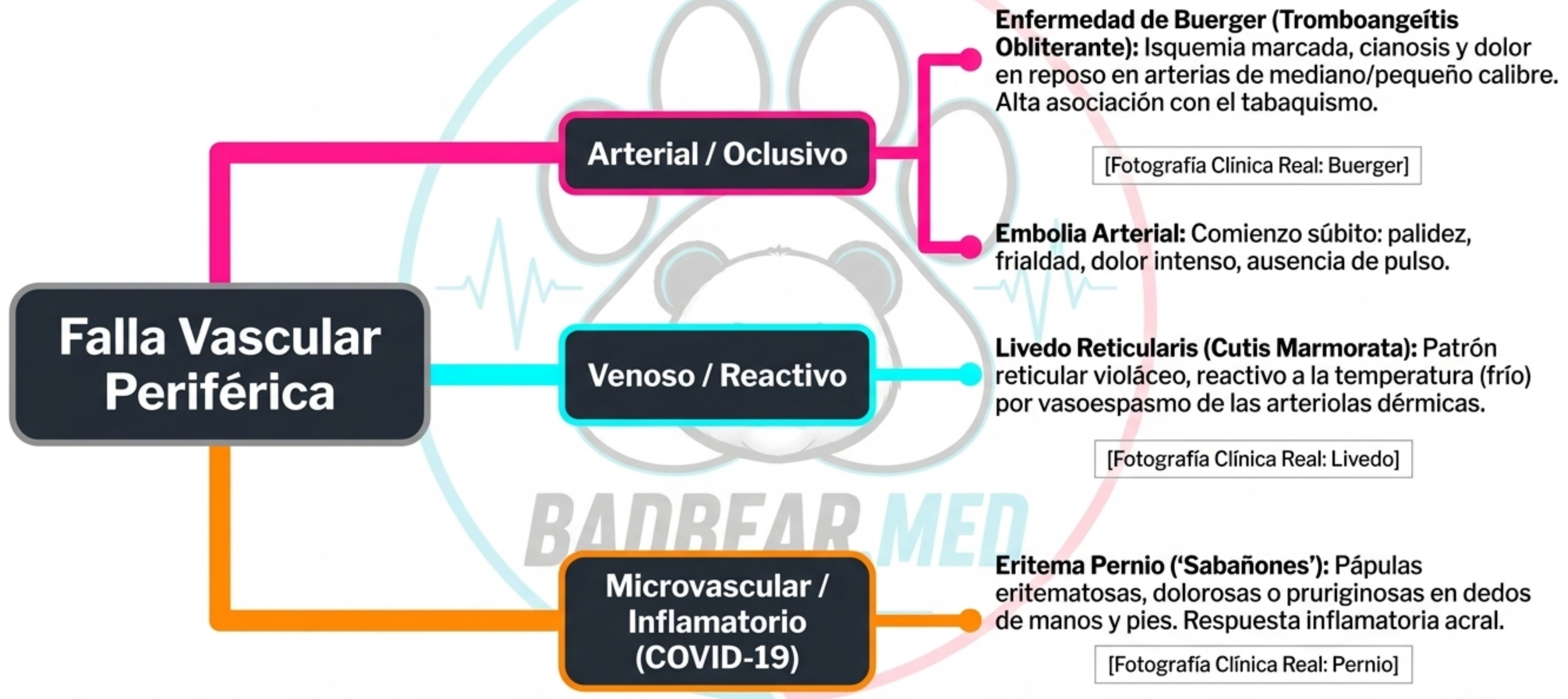
[Fotografía Clínica Real:
Angiofibromas]

Síndrome de Sturge-Weber

- Mancha en Vino de Oporto (Afección vascular V1/hemicara).
- Glaucoma.
- Malformaciones leptomeníngicas (parieto-occipitales).

[Fotografía Clínica Real:
Mancha en Vino de Oporto]

Trastornos Vasculares Periféricos



Dermatosis Paraneoplásicas I: Foco Gastrointestinal

Alerta Cutánea

Sospecha Oncológica

Acantosis Nigricans Maligna: Aparición brusca y exuberante en grandes pliegues en adultos mayores

Cáncer de Estómago

[Fotografía Clínica Real]

Signo de Leser-Trélat: Erupción súbita (semanas) de múltiples queratosis seborreicas en tronco/rostro

Cáncer de Estómago

[Fotografía Clínica Real]

Síndrome de Peutz-Jeghers: Mutación gen LKB1. Múltiples máculas melánicas en labios y mucosa oral. Asociado a pólipos hamartomatosos

Adenocarcinoma de Colon/Recto

[Fotografía Clínica Real]

Queratoderma Palmoplantar: Engrosamiento anormal y doloroso adquirido

Cáncer de Estómago o Pulmón

Dermatosis Paraneoplásicas II: Foco Sistémico

Signo de Trousseau (Tromboflebitis Migratoria): Trombosis segmentaria superficial que migra en días. Por hipercoagulabilidad tumoral.
-> **Cáncer de Páncreas y Pulmón.**

[Fotografía Clínica Real]

Enfermedad de Paget Extramamaria: Placa eritematosa exudativa en grandes pliegues (adenocarcinoma intraepitelial).
-> **Tumores de Vejiga, Recto, Colon.**

Ictiosis Adquirida: Piel seca y escamosa (apariciencia de pescado) de aparición tardía.
-> **Linfoma de Hodgkin.**

[Fotografía Clínica Real]

Eritema Gydatum Repens: Lesiones eritematosas descamativas serpiginosas (forma de anillo/serpiente) que avanzan rápidamente (días).
-> **Cáncer de Mama, Pulmón, Esófago.**

[Fotografía Clínica Real]